



UNOESTE | 2023

R1 ACESSO DIRETO

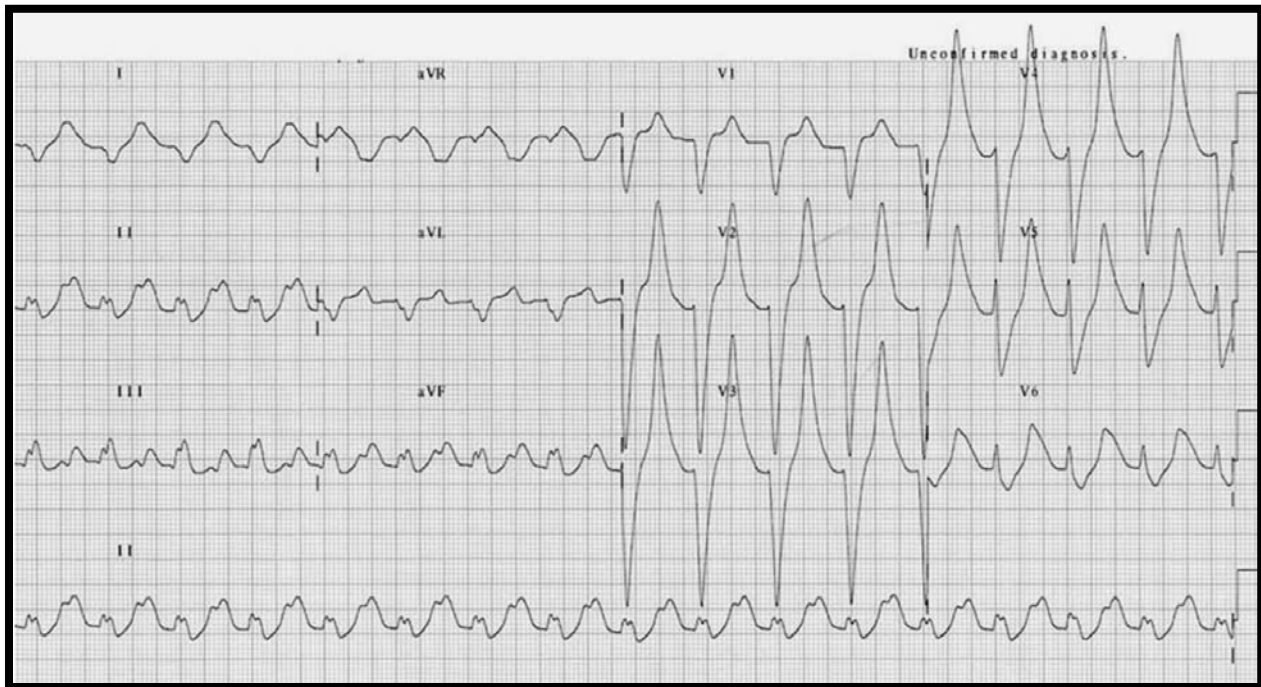
1) Mulher, 43 anos, refere história de perda de peso, aumento de apetite, palpitação, sudorese, tremores de extremidades e protusão ocular há 6 meses. Há 1 dia, refere tosse produtiva, com expectoração amarelada, febre de até 39 °C e queda do estado geral. Trazida ao pronto atendimento por familiares, apresenta-se torporosa, desidratada, febril (38,8 °C), taquicárdica (frequência cardíaca = 135 bpm), sudorética, PA = 90 x 45 mmHg e com perfusão periférica lentificada. Foi realizada expansão volêmica vigorosa e iniciada antibioticoterapia empírica. Com base na apresentação clínica e na confirmação da principal suspeita diagnóstica, assinale a alternativa correta.

- A) A administração de solução saturada de iodeto de potássio deve ser a próxima medida terapêutica a ser instituída.
- B) Para o diagnóstico de crise tireotóxica, é necessário o achado de concentrações plasmáticas de TSH < 0,01 um/L, T4 livre > 6 nmol/L e/ou T3 livre > 4 nmol/L.
- C) Dexametasona está indicada apenas se não houver melhora em relação às demais medidas após 24 horas.
- D) Metimazol deve ser iniciado prontamente, e é preferível ao propiltiuracil devido à sua meia-vida plasmática maior.
- E) O tratamento correto é feito preferencialmente com propiltiuracil e dexametasona.

2) Um paciente é trazido à sala de emergência em parada cardiorrespiratória. Foi constatada parada cardíaca em atividade elétrica sem pulso. Seguindo as diretrizes mais atuais, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.

- A) A atropina foi reintroduzida no protocolo como opção à epinefrina.
- B) A vasopressina alternada à epinefrina ou à atropina, em intervalos de 3 a 5 minutos, é uma estratégia aceita.
- C) As drogas apresentam papel secundário nas diretrizes atuais, podendo ser utilizadas compressões torácicas isoladamente.
- D) Aplicar epinefrina logo após a detecção do ritmo não chocável.
- E) Iniciar as compressões e somente introduzir drogas no protocolo após o primeiro ciclo.

3) Homem, 64 anos, foi admitido no pronto-socorro com quadro de fraqueza nas pernas e palpitações há dois dias, tendo apresentado síncope há duas horas. É portador de diabetes mellitus há 20 anos, com retinopatia, doença renal crônica estágio 3b e miocardiopatia isquêmica com fração de ejeção levemente reduzida. Faz uso contínuo de insulina NPH, losartana, carvedilol e AAS, com uso esporádico de furosemida. Há 15 dias, foi associada espironolactona pelo antecedente de miocardiopatia. Na admissão, paciente encontra-se com PA = 110 x 70 mmHg, taquipneico leve e euvolêmico. O eletrocardiograma realizado na admissão está ilustrado a seguir. Com base no exposto, assinale a afirmativa correta.



- A) A principal medida a ser realizada é encaminhar o paciente para trombólise ou angioplastia primária.
- B) O uso de diurético de alça é contraindicado pelo risco de agravamento do quadro cardíaco.
- C) A infusão de gluconato de cálcio endovenoso terá efeito protetor sobre as células miocárdicas.
- D) A administração de amiodarona endovenosa é essencial para a prevenção de arritmias graves nesse paciente.
- E) A administração de insulina e glicose está contraindicada pelo risco elevado de hipoglicemia.

4) Mulher, 36 anos, tem antecedentes de hipertensão arterial e troca valvar mitral por prótese metálica há 9 anos. Está em uso regular de enalapril 10 mg 12/12h e varfarina 5 mg/dia, com bom controle dos níveis pressóricos e do tempo de protrombina. Após atraso menstrual, procurou ginecologista e foi confirmada gravidez. Encontra-se na 6ª semana de gestação, confirmada por ultrassonografia transvaginal. Qual é a conduta correta neste momento?

- A) Manter o enalapril, pois está em controle adequado da hipertensão arterial. Manter a varfarina, pois a terapêutica encontra-se otimizada.
- B) Substituir enalapril por metildopa e varfarina por heparina de baixo peso molecular.
- C) Substituir enalapril por hidralazina. Manter o uso de varfarina até a 12ª semana e, após, substituir por heparina de baixo peso molecular.
- D) Substituir enalapril por nifedipina. Manter o uso de varfarina até a 36ª semana e, após, substituir por enoxaparina.
- E) Manter o enalapril e substituir a varfarina por apixabana.

5) Jovem do sexo masculino, 22 anos, é encaminhado ao ambulatório para avaliação de hipertensão arterial sistêmica. Não apresenta antecedentes familiares relevantes e não faz uso de medicamentos ou substâncias ilícitas. O exame físico revela: desdobramento fisiológico de B2 e hiperfonese da segunda bulha em foco aórtico, além de sopro sistólico ejetivo ao longo do bordo esternal esquerdo. O paciente traz uma radiografia de tórax com o seguinte achado, ampliado no detalhe: Em face do exposto, é correto afirmar que a causa mais provável da hipertensão arterial é secundária



- A) à coarctação da aorta.
- B) à síndrome de Cushing.
- C) ao hiperparatireoidismo.
- D) à apneia do sono.
- E) ao hipotireoidismo.

6) Homem, 33 anos, atleta de crossfit e sem comorbidades, é admitido no pronto atendimento por mialgia intensa há 5 dias, evoluindo com náuseas, vômitos, inapetência e queda do estado geral há 1 dia. Exames laboratoriais evidenciaram creatinina = 6,82 mg/dL, ureia 202 mg/dL e exame de urina com hemácias 2/campo e hemoglobina + + + +. O principal mecanismo fisiopatológico da insuficiência renal aguda desse paciente é:

- A) isquemia renal medular.
- B) depósito de imunocomplexos em glomérulo.
- C) obstrução tubular por pigmentos heme em associação com ácido úrico.
- D) dilatação de arteríola eferente glomerular.
- E) ação direta de toxinas no túbulo distal.

7) Mulher, 66 anos, portadora de cirrose hepática Child B por esteato-hepatite não alcoólica, é trazida ao pronto atendimento por desorientação e sonolência há 24 horas. Faz uso de furosemida, espironolactona, propranolol e lactulose. Exame físico: escala de coma de Glasgow = 10 (A02 RV3 RM5), presença de flapping, exame abdominal com ascite não tensa e toque retal com melena. Exames laboratoriais evidenciam hemograma e eletrólitos sem alterações. Realizada paracentese diagnóstica com achado de 230 leucócitos por mm³, sendo 70% de neutrófilos. Qual é o mais provável fator desencadeante do quadro de encefalopatia da paciente?

- A) Excesso de diuréticos.
- B) Gastroenterocolite aguda.
- C) Constipação.
- D) Peritonite bacteriana espontânea.
- E) Hemorragia digestiva alta.

8) Homem, 28 anos, sem comorbidades, há 4 dias apresenta dor, edema e eritema em joelho direito, associado a queda do estado geral e inapetência. Nega febre, lesões de pele, acometimento ocular. Ao exame físico, apresenta sinovite de joelho direito e bloqueio articular, sem acometimento de demais articulações. Nesse caso, a principal hipótese diagnóstica é

- A) espondiloartropatia soronegativa.
- B) gota.
- C) lúpus eritematoso sistêmico.
- D) artrite reumatoide.
- E) artrite séptica.

9) Mulher, 78 anos, internada após queda da própria altura e fratura de fêmur, cursa com diarreia líquida com muco, mais de 10 evacuações ao dia, associada a febre baixa e dor abdominal. Usou diversos esquemas de antibioticoterapia durante a internação por infecção de sítio cirúrgico. O resultado da pesquisa de toxinas A e B do *Clostridioides difficile* foi negativo.

A paciente foi tratada com metronidazol, via oral, sem resposta clínica. Com base no caso clínico, assinale a alternativa correta.

A) Provavelmente, se trata de incontinência fecal e a loperamida está bem indicada nesse caso.

B) A infecção por *C. difficile* ainda deve ser considerada a hipótese diagnóstica mais plausível, e a sua pesquisa por PCR deve ser realizada.

C) A colonoscopia com biópsia seriada é recomendada em todos os casos de suspeita de infecção por *C. difficile* em que não houve comprovação laboratorial.

D) A infecção por *C. difficile* foi descartada pela alta acurácia diagnóstica da pesquisa de toxinas. A paciente deve ser tratada com ajuste da dieta e probióticos.

E) Não se pode descartar a presença de infecção por *C. difficile*, porém não há necessidade de complementação diagnóstica e o metronidazol deve ser mantido por 4 semanas.

10) Homem, 57 anos, encontra-se em avaliação ambulatorial para seguimento de diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia. Refere antecedentes de tabagismo, etilismo social e infarto do miocárdio com angioplastia primária de descendente anterior há 1 ano. Nega sintomas atuais e refere que faz caminhadas diárias de 50 minutos. Visando minimizar o risco cardiovascular desse paciente, assinale a alternativa que compreende as metas de controle glicêmico, lipídico e pressórico.

A) HbA1c < 6,5%; LDL < 50 mg/dL; PA < 130 x 80 mmHg.

B) HbA1c < 6,5%; LDL < 100 mg/dL; PA < 140 x 90 mmHg.

C) HbA1c < 7,0%; LDL < 50 mg/dL; PA < 130 x 80 mmHg.

D) HbA1c < 7,0%; LDL < 100 mg/dL; PA < 140 x 90 mmHg.

E) HbA1c < 7,5%; LDL < 70 mg/dL; PA < 130 x 85 mmHg.

11) Mulher, 47 anos, apresenta episódios de palpitações, sudorese, dispneia, tremores e medo imotivado, que ocorrem subitamente, em crises. Refere que já foi ao pronto atendimento diversas vezes nos últimos anos, onde realizou exames séricos, eletrocardiograma e marcadores cardíacos, sempre com resultados normais. Assinale a alternativa que contém, correta e respectivamente, o diagnóstico e conduta inicial.

A) Depressão – sertralina 50 mg e reavaliar em 4 a 6 semanas.

B) Depressão – fluoxetina 20 mg e reavaliar em 2 semanas.

C) Transtorno de pânico – venlafaxina XR 37,5 mg e reavaliar em 4 a 6 semanas.

D) Transtorno de pânico – amitriptilina 100 mg e reavaliar em 8 semanas.

E) Síndrome conversiva – encaminhar para psicoterapia.

12) Mulher, 72 anos, hipertensa e diabética, deu entrada no pronto atendimento com desvio de rima labial para esquerda e hemiparesia à direita, que começou há 2 horas da admissão. Sinais vitais da admissão: PA = 170 x 100 mmHg, FC = 89 bpm, FR = 14 ipm, SpO2 = 95% em ar ambiente. Foi realizada tomografia de crânio conforme imagem a seguir.

Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o diagnóstico e conduta corretos, considerando que não existem contraindicações ao tratamento escolhido.



- A) Acidente vascular cerebral hemorrágico. Arteriografia e embolização.
- B) Acidente vascular cerebral hemorrágico. Craniectomia descompressiva.
- C) Acidente vascular cerebral isquêmico. Trombólise química.
- D) Acidente vascular cerebral isquêmico. Transferência para UTI e trombólise química em até 12 horas.
- E) Acidente vascular cerebral isquêmico. Craniectomia descompressiva.

13) Mulher, 66 anos, procura atendimento por febre diária há cerca de três dias, associada a calafrios e dor no membro inferior esquerdo, onde surgiu uma extensa área hiperemiada. Relata antecedente pessoal de hipertensão arterial sistêmica em uso de enalapril 5 mg 2x/dia. Exame físico: Glasgow 15, ausculta cardíaca e pulmonar normais; propedêutica abdominal normal; membro inferior direito sem achados, membro inferior esquerdo com achados sugestivos de erisipela infecciosa. Para a terapêutica apropriada, é fundamental o conhecimento de que o principal agente etiológico envolvido é:

- A) *Haemophilus influenzae*.

- B) bacteroides fragilis.
- C) staphylococcus aureus.
- D) streptococcus pyogenes.
- E) escherichia coli.

14) Mulher, 54 anos, com antecedente de câncer de mama e insuficiência cardíaca, começou a cursar com quadro de tosse e dispneia. Foi internada para investigação diagnóstica. Radiografia de tórax constatou moderado derrame pleural à direita. A paciente foi submetida à toracocentese diagnóstica e de alívio. Resultados da análise laboratorial: albumina sérica = 3,2 g/dL; proteínas totais sérica = 6,5 g/dL; DHL sérico = 160 (VR 250) UI/L; albumina líquido pleural = 1,9 g/dL; proteínas totais no líquido pleural = 2,6 g/dL; DHL no líquido pleural = 80 UI/L. Quanto aos quesitos: classificação do líquido e causa mais provável, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a informação correta.

- A) Exsudato – câncer de mama.
- B) Exsudato – insuficiência cardíaca.
- C) Indeterminado – não é possível estabelecer sua provável causa.
- D) Transudato – insuficiência cardíaca.
- E) Transudato – câncer de mama.

15) Homem, 74 anos, apresenta quadro de dor no ombro direito, fraqueza e atrofia dos músculos intrínsecos da mão há 2 meses. Ao exame físico, apresenta ptose palpebral à direita associada a miose ipsilateral. O quadro clínico pode ser mais provavelmente explicado por

- A) neoplasia tipo não pequenas células do pulmão.
- B) doença de Addison.
- C) tumor neuroendócrino do intestino.
- D) tuberculose pulmonar.
- E) esclerose múltipla.

16) Homem, portador de hipertensão arterial sistêmica, encontra-se em uso regular de hidroclorotiazida, valsartana, anlodipina e metoprolol, em doses máximas. Em retorno ambulatorial, permanece hipertenso, com níveis pressóricos em torno de 165 x 105 mmHg, que foi confirmado pela monitorização ambulatorial de 24 horas (MAPA). O fármaco indicado para esse momento deve ser

- A) a espironolactona.
- B) o diltiazem.
- C) o alisquireno.
- D) a hidralazina.
- E) a alfametildopa.

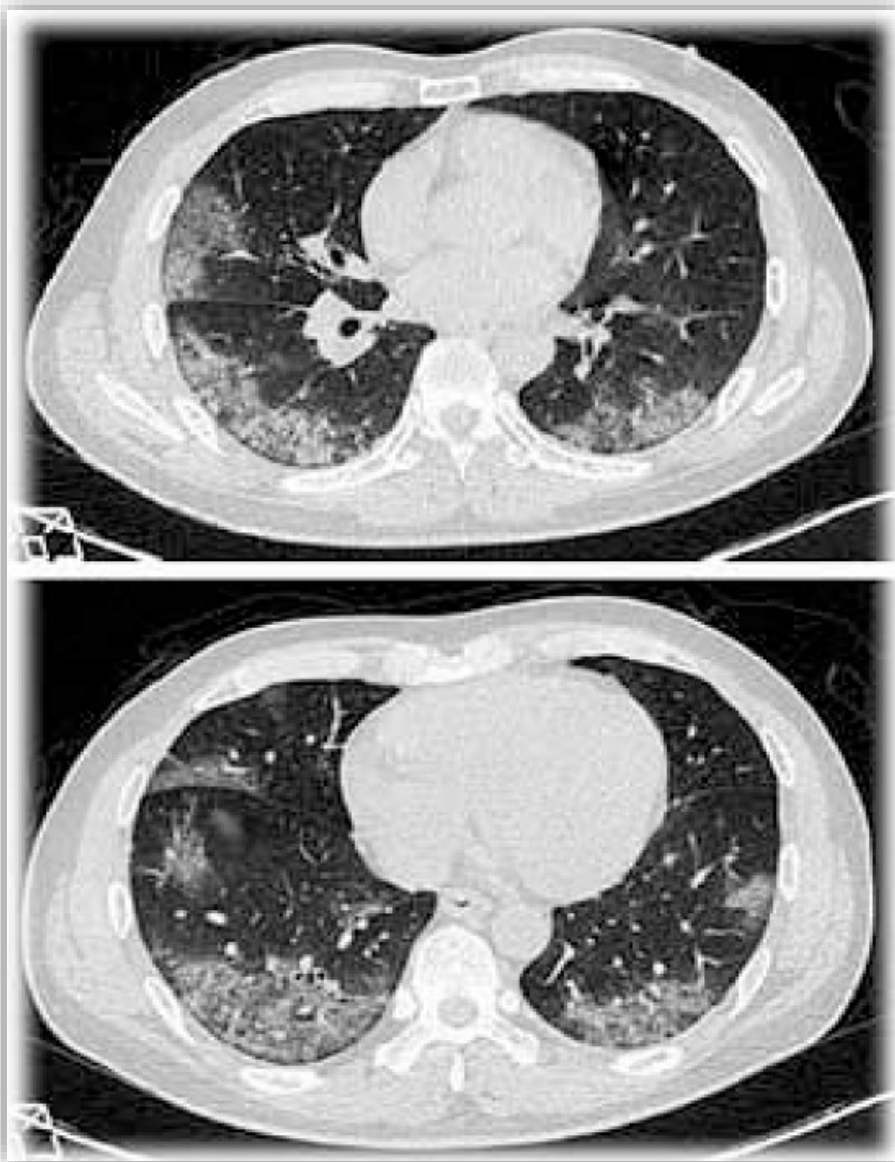
17) Mulher, 68 anos, apresenta adinamia e cansaço aos esforços. Exame físico: palidez cutâneo-mucosa. Exames laboratoriais: Hb = 9,9 g/dL, VCM = 118 fl, CHCM = 31%, leucócitos = 3090/mm³ (45% de segmentados, 3% de monócitos e 52% de linfócitos), plaquetas = 79500/mm³ e reticulócitos = 0,6%. São observadas as seguintes alterações no esfregaço de sangue periférico: macrocitose, com neutrófilos multissegmentados e plaquetas aumentadas de tamanho. Durante a investigação diagnóstica, a paciente realizou endoscopia digestiva alta que revelou gastrite em fundo e corpo do estômago. Os achados laboratoriais compatíveis, considerando a hipótese diagnóstica mais provável, são

- A) DHL e ácido metilmalônico elevados.
- B) homocisteína normal com ácido metilmalônico diminuído.
- C) DHL normal e ácido metilmalônico diminuído.
- D) TSH elevado e T4 livre suprimido.
- E) TSH suprimido e T4 livre aumentado.

18) Homem, 66 anos, apresenta quadro de agressividade alternada com períodos de sonolência, há 2 dias. Familiares que o trouxeram à emergência do hospital referem que, acompanhando o quadro, o paciente apresenta febre de até 39 °C, sem melhora com o uso de analgésicos ou antitérmicos. Avaliação clínica inicial: paciente torporoso, com Glasgow = 10; PA = 140 x 100 mmHg; ausência de rigidez de nuca; as ausculta cardíaca e respiratória são normais. A ressonância magnética do crânio evidenciou áreas de aumento da intensidade do sinal em ambas as regiões frontotemporais, com aumento do sinal em T2. Foi coletado líquido, e o resultado é aguardado. Com base na hipótese diagnóstica mais provável, o tratamento curativo correto deve ser feito com

- A) ceftriaxona.
- B) dexametasona.
- C) rifampicina, pirazinamida, isoniazida e etambutol.
- D) neurocirurgia.
- E) aciclovir.

19) Homem, 39 anos, obeso e dislipidêmico, procurou atendimento médico ambulatorial devido sensação de febre (não medida), tosse seca e odinofagia há seis dias. Recebeu medicação sintomática e aconselhamento para manter-se em repouso relativo domiciliar. Dois dias após o atendimento inicial, necessitou internação hospitalar por piora clínica, tosse mais acentuada e dispneia em repouso. Exame físico: regular estado geral, corado, hidratado, anictérico, acianótico e taquipneico leve; PA = 120 x 80 mmHg; SpO₂ em ar ambiente = 86%; ausculta pulmonar com estertores difusos e com tiragem intercostal leve. Foi realizada tomografia de tórax, conforme ilustração a seguir. Com base no caso clínico, assinale a alternativa correta.



A) Trata-se de uma síndrome respiratória aguda grave em que a etiologia bacteriana é a mais provável.

B) A coleta de swab nasal e pesquisa do SARSCOV-2 é mandatória e o paciente deve permanecer internado.

C) A hemocultura é fundamental para o diagnóstico etiológico nesse caso.

D) A realização de pulsoterapia com corticoide por 5 dias é o tratamento padrão.

E) O paciente deve receber prednisona oral, azitromicina e inalações com broncodilatadores, em regime de tratamento ambulatorial.

20) Mulher, 57 anos, portadora de insuficiência renal crônica pré-dialítica, procura a emergência de um hospital apresentando queixa de mal-estar, desconforto torácico inespecífico, náuseas e vômitos há 2 dias. O exame físico evidencia hálito urêmico, atrito pericárdico e presença de pulso paradoxal. Foi realizado eletrocardiograma de repouso

que não evidenciou alterações do segmento ST. Com base no caso clínico, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A causa mais provável é pericardite tuberculosa.
- B) O achado de pulso paradoxal não sinaliza gravidade no caso em questão.
- C) O quadro sugere síndrome coronariana aguda, e a paciente deve ser encaminhada ao cateterismo cardíaco.
- D) Há indicação absoluta de hemodiálise.
- E) A ausência de alterações no segmento ST afasta a possibilidade de pericardite.

21) Durante a avaliação primária do paciente politraumatizado, deve ser realizada a avaliação neurológica pela etapa Disability, cujos objetivos são essencialmente

- A) avaliar a resposta aos reflexos profundos do abdome e membros inferiores, para detectar nível de lesão medular, se estiver presente.
- B) avaliar nível de consciência pela Escala de Coma de Glasgow, reflexos pupilares e sinais de lateralização.
- C) testar os reflexos de todos os nervos cranianos centrais e reflexos medulares superiores e inferiores.
- D) avaliar o nível do trauma vertebromedular pela ressonância nuclear magnética e lesão cerebral aguda.
- E) avaliar os reflexos pupilares e detectar as síndromes medulares centrais por exames de imagem.

22) Mulher de 19 anos, motociclista, sofreu acidente com linha de cerol e deu entrada na emergência apresentando sangramento e escape de ar em grande quantidade pelo ferimento cervical. Sinais vitais: saturação O₂: 75%; PA: 88/56 mmHg; FC: 132 bpm; FR: 26 mrpm. Após os cuidados iniciais, deve-se indicar

- A) angiotomografia cervical.
- B) endoscopia digestiva alta.
- C) RX simples do pescoço (PA/P).
- D) traqueolaringoscopia direta.
- E) cervicotomia exploradora.

23) Muitos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos abdominais podem desenvolver íleo pós-operatório, que afeta o estômago e o cólon primariamente. Acerca da motilidade gastrointestinal após laparotomias, assinale a alternativa correta.

- A) A motilidade do intestino delgado retorna após 5 dias.
- B) A motilidade gástrica retorna em 72 horas.
- C) A motilidade colônica retorna em 48 a 72 horas.

D) Deve-se estimular o retorno da motilidade pós laparotomias com fármacos pró cinéticos.

E) A deambulação precoce não tem impacto na motilidade gastrointestinal e deve ser evitada pelo risco de tromboembolismo pulmonar.

24) Menino de 9 anos de idade com dor escrotal esquerda há 2 dias, inicialmente de fraca intensidade, aumentando progressivamente. Nega náuseas ou vômitos. Ao exame físico, apresenta febre (37,8 °C), dor, hiperemia e edema em bolsa testicular esquerda, aumento de volume testicular com reflexo cremastérico presente. Sinal de Prehn presente. Dentre as alternativas abaixo, qual a hipótese diagnóstica mais provável?

A) Hérnia inguinoescrotal.

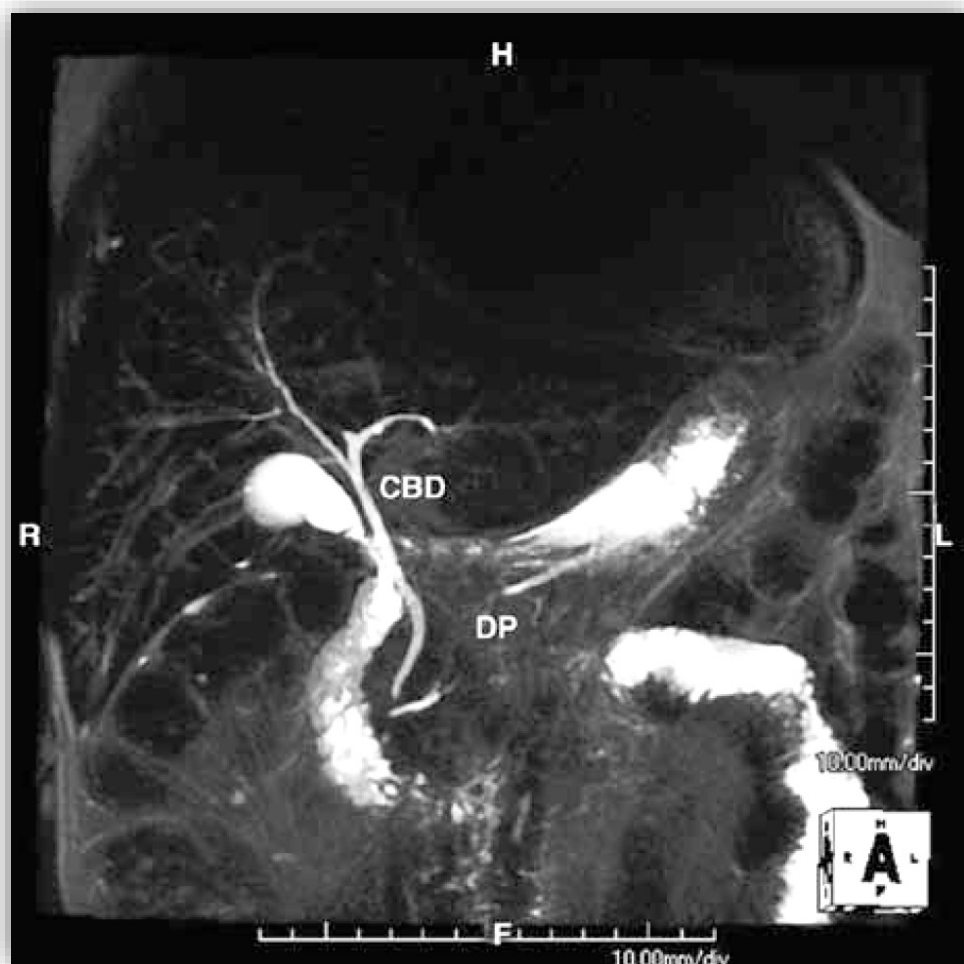
B) Hidrocele.

C) Torção de testículo.

D) Orquiepididimite.

E) Criptorquidia.

25) Homem de 70 anos procurou atendimento médico por apresentar desconforto abdominal em região epigástrica há 2 meses, com irradiação para hipocôndrio direito, acompanhada de náuseas e icterícia que se iniciou há 2 semanas. Nega vômitos, febre ou emagrecimento. Refere ter sido submetido a laparotomia há 23 anos por ferimento penetrante abdominal. Ao exame: icterícia evidente, sinais vitais normais, sem alterações no exame abdominal. O médico solicitou exames laboratoriais, que detectaram aumento expressivo da bilirrubina indireta e transaminases (fosfatase alcalina e GGT normais) e exames de imagem – ultrassom de abdome superior normal e colangioressonância abaixo demonstrada. Diante dos achados, o médico deverá solicitar, na investigação do paciente:



A) sorologia completa para hepatites, pois os dados clínicos e de imagem estão normais, e a hipótese de icterícia obstrutiva é remota.

B) pancreatografia retrógrada endoscópica para remoção de cálculo encravado em papila duodenal maior.

C) endoscopia digestiva alta com biópsia de tumor duodenal causando compressão extrínseca da via biliar principal.

D) videolaparoscopia com remoção cirúrgica de cálculos coledocianos, causadores do quadro de icterícia obstrutiva.

E) biópsia hepática guiada por ultrassonografia, pois há fortes evidências de carcinoma hepatocelular, demonstrado nas imagens da colangioressonância.

26) Mulher de 67 anos comparece ao pronto atendimento devido a dor torácica com irradiação para o dorso. Refere quadro semelhante por 3 ocasiões nos últimos 3 meses, sem história de trauma prévio. A dor é de forte intensidade e sem fatores de melhora ou piora. Hipertensa, tabagista 40 maços/ano. Na sua primeira avaliação, solicitou-se uma radiografia de tórax (imagem demonstrada). Em relação ao quadro clínico e à imagem, pode-se afirmar que



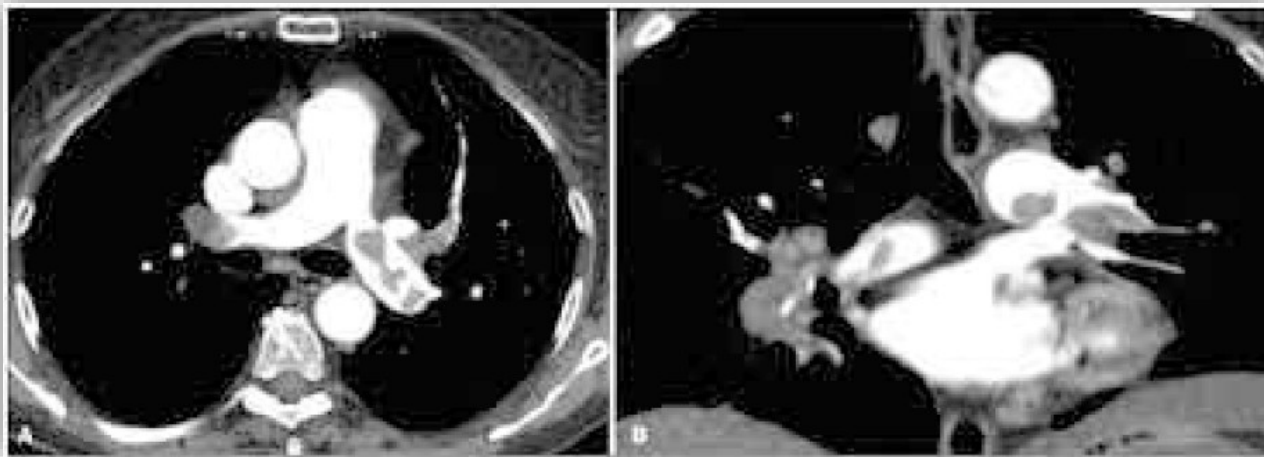
- A) há presença de alargamento de mediastino, podendo sugerir aneurisma de aorta torácica.
- B) a radiografia foi bem realizada, com boa inspiração e boa penetração e sem rotação.
- C) o índice cardioriorácico medido foi de 0,4, sugerindo cardiomegalia importante.
- D) na avaliação do ar presente na traqueia, podemos afirmar que há desvio dessa estrutura.
- E) há forte indício de hemotórax à esquerda.

27) Mulher de 32 anos de idade apresenta quadro súbito de dor pleurítica à direita, acompanhada de dispneia. Deu entrada no PS estável, sinais vitais normais, tendo sido efetuados exames de imagem (demonstrados). Com base na história clínica e nas imagens, o diagnóstico mais provável é



- A) pneumotórax hipertensivo.
- B) atelectasia em pulmão direito.
- C) dispneia neurogênica por stress.
- D) atelectasia à direita.
- E) pneumotórax espontâneo.

28) Mulher, 32 anos, foi admitida no Pronto Socorro com quadro de dispneia aos mínimos esforços, iniciada há 5 horas, dor torácica ventilatório-dependente à esquerda e dor em MMII há 1 semana. Ao exame físico, apresentava FC de 145 bpm, com ritmo regular, FR de 36 irpm, PA de 110 x75 mmHg, Sat O₂ de 88%, T = 35 °C. A ausculta cardíaca mostrava ritmo regular, 2T, com hiperfonese de B2 em foco pulmonar, sem sopros. No exame pulmonar, expansibilidade diminuída em bases, FTV diminuído, macicez em base esquerda e MV diminuídos difusamente. Abdomen sem alterações. Apresentava edema em MMII direito (+++/IV) mole e indolor, sem dor a dorso-flexão, presença de varizes em MMII. Teve 01 parto há 1 mês, cesariana com complicação e hospitalização por 1 semana. Tomografia de tórax demonstrada a seguir. O diagnóstico da paciente é



- A) broncopneumonia.
- B) tromboembolismo pulmonar.
- C) covid-19 (vidro fosco).
- D) angiossarcoma.
- E) dissecação da aorta torácica.

29) Com relação ao trauma uretral, assinale a alternativa correta.

- A) As lesões de uretra anterior estão associadas à fratura de pelve.
- B) É um tipo de trauma muito comum e predomina no sexo feminino.
- C) A sua etiologia mais comum é consequência de lesões iatrogênicas.
- D) Na grande maioria dos casos, a uretra posterior é a porção mais acometida.
- E) O método padrão para o diagnóstico definitivo de trauma uretral é a uretroscopia.

30) Com relação ao tratamento cirúrgico das hemorroidas, após a ressecção das mesmas, pode-se empregar a técnica de Ferguson, que consiste em

- A) fechamento da ferida cirúrgica em sutura contínua com fio absorvível, a fim de diminuir a dor pós-operatória e melhorar o aspecto estético.
- B) excisão cirúrgica dos mamilos hemorroidários e a sua ligadura vascular; a ferida operatória fica aberta (cicatrização por segunda intenção).
- C) empregar um doppler que, durante a cirurgia, é inserido no canal anal do paciente para identificar o fluxo vascular; com uma agulha que passa pelo seu interior (sem oferecer risco de lesão de tecidos), o cirurgião sutura a veia em um ponto específico, cessando a causa da doença.
- D) utilizar um grampeador circular, capaz de remover a submucosa e o excesso de mucosa próximo à linha pectínea (linha de sensibilidade do ânus).
- E) ligadura dos pedículos vasculares dos mamilos hemorroidários com 2 a 3 elásticos, associada a laserterapia.

31) “Fio sintético, polímero da poliparadioxanona (polidioxanona), é um fio que tem a vantagem de ser monofilamentado, e possuir uma absorção lenta com manutenção da resistência tênsil por longo período. Devido a esta característica, é utilizado na sutura de tendões, cápsulas articulares e fechamento da parede abdominal.”

Essa descrição corresponde a qual fio cirúrgico?

- A) Nylon.
- B) Vicryl®.
- C) Dexon®.
- D) PDS®.
- E) Categute.

32) Homem, 73 anos, com queixa de dor lombar de forte intensidade há três meses e diagnóstico recente de Diabetes Mellitus, foi submetido a uma tomografia de abdome que demonstra lesão sólida heterogênea em cabeça de pâncreas de 2,5 cm e dilatação do ducto pancreático principal (7,0 mm), sem outros achados (sem evidência de envolvimento da veia mesentérica superior ou da veia porta (i. e., sem fixação, distorção, trombo ou confinamento) e uma superfície gordurosa preservada circundando a artéria mesentérica superior e os ramos da artéria celíaca, incluindo a artéria hepática). No estadiamento, ausência de linfonodos regionais e ausência de metástases. Quais são o provável diagnóstico e a conduta?

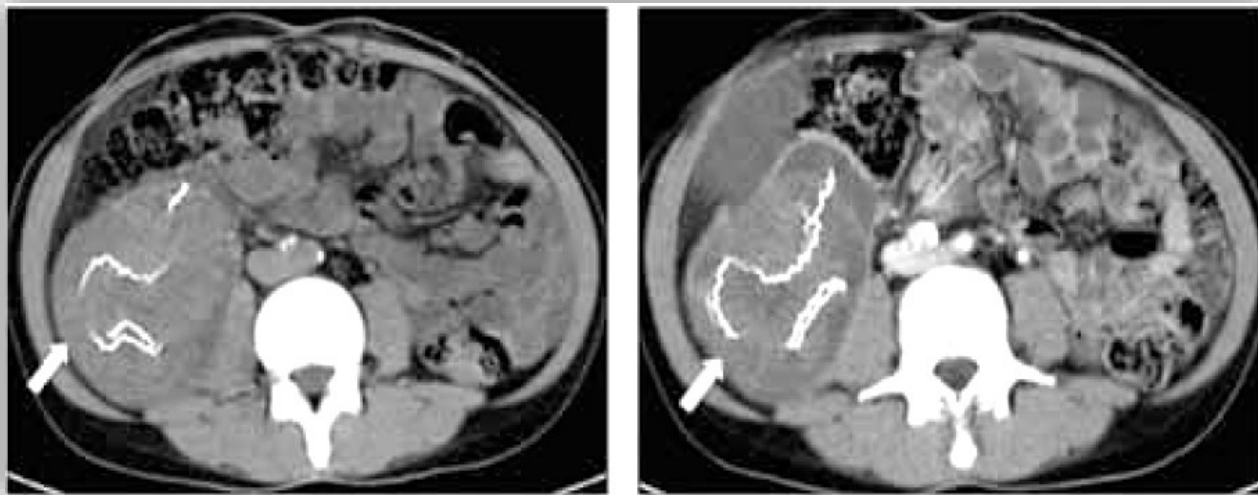
- A) Neoplasias intraductais mucinosas (IPMN) de ducto principal; observação e ressecção se estigmas de alto risco.
- B) Neoplasia papilar mucinosa intra ductal; observação e ressecção se estigmas de alto risco.
- C) Adenocarcinoma ductal de pâncreas; pancreatoduodenectomia.
- D) Neoplasia cística serosa; observação e ressecção se sintomas.
- E) Metástase pancreática de colangiocarcinoma das vias biliares; drenagem da papila com stent por via endoscópica.

33) Homem de 64 anos é atendido na Emergência após acidente automobilístico. De acordo com relato do APH, o paciente era condutor do veículo e o volante encontrava-se deformado na cena. Apresenta contusões e escoriações na parede torácica e abdominal. Ao exame clínico, encontra-se ansioso e agitado, com PA 115 x 75 mmHg, pulso: 78 bpm, FR: 26 irpm e saturação de oxigênio de 89%. Relata falta de ar e dor à palpação do abdome. O murmúrio vesicular está diminuído na base esquerda. RX tórax demonstrado a seguir. Quais são o diagnóstico e a conduta indicada?



- A) Hemopneumotórax à esquerda; drenagem torácica.
- B) Contusão pulmonar grave; toracotomia.
- C) Pneumatocele; toracotomia.
- D) Atelectasia e condensação à esquerda; ventilação assistida com pressão positiva.
- E) Hérnia diafragmática à esquerda; videolaparoscopia.

34) Homem de 17 anos deu entrada na emergência em choque hemorrágico grave devido a ferimento penetrante abdominal, e foi submetido a uma laparotomia exploradora, sendo encontrada volumosa quantidade de sangue intraperitoneal, e submetido a sutura hepática e gástrica. No pós-operatório, o paciente evoluiu com febre, distensão e dor abdominal. Submetido à tomografia abdominal (demonstrada a seguir). O diagnóstico da lesão (setas) é



- A) abscesso multiloculado.
- B) gossibipoma abdominal.
- C) bilioma secundário.
- D) hematoma subcapsular hepático.
- E) lipólise mesentérica primária.

35) Mulher, 54 anos, obesa, é diagnosticada com doença do refluxo gastroesofágico. Durante o acompanhamento da doença, foi requisitada uma endoscopia digestiva alta com biópsia do terço final do esôfago, na qual foi observado um processo adaptativo do epitélio esofágico, em que houve substituição do epitélio de revestimento normal do esôfago por um mais adaptado à agressão do ácido gástrico (como representado na imagem a seguir). Qual é o processo patológico específico observado no exame histológico do esôfago neste caso?



- A) Metaplasia de células escamosas do tipo esofágica.
- B) Hiperplasia de células colunares do tipo intestinal.
- C) Metaplasia de células colunares do tipo intestinal.
- D) Atrofia de células escamosas do tipo intestinal.
- E) Displasia de células escamosas de 3º grau.

36) Homem de 56 anos vem apresentando alteração do hábito intestinal, dor abdominal e hematoquezia há 3 meses. Realizou colonoscopia que evidenciou uma lesão vegetante ulcerada no cólon ascendente com 3,0 cm e outra lesão com 2,0 cm no cólon transverso, apresentando as mesmas características. As biópsias das lesões foram compatíveis com adenocarcinoma pouco diferenciado. Estudo imuno-histoquímico mostrou mutação de genes MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 e EPCAM. O paciente informou que o pai teve câncer de cólon aos 52 anos e a irmã, aos 48 anos. O quadro clínico é sugestivo de

- A) polipose adenomatosa familiar (PAF).
- B) síndrome de Turcot.
- C) síndrome de Lynch (HNPCC).
- D) síndrome de Gardner.
- E) tumores carcinóides do cólon.

37) Alguns pacientes apresentam evolução de quadro de apendicite aguda para perfuração apendicular com bloqueio local (não difuso); este subgrupo costuma procurar o serviço médico com vários dias de evolução, apresentando plastrão palpável em fossa ilíaca direita e,

por vezes, complicações locais com abscesso. Tais pacientes, após confirmação diagnóstica por exame de imagem (tomografia), podem se beneficiar, atualmente, de qual das condutas seguintes?

- A) Apendicectomia de intervalo.
- B) Apendicectomia tradicional por incisão Mc Burney.
- C) Melhor elucidação diagnóstica por colonoscopia.
- D) Hemicolectomia direita.
- E) Apendicectomia por via endoscópica.

38) A realização da tomografia computadorizada em um paciente com pancreatite aguda, em uma fase precoce, pode demonstrar heterogeneidade do parênquima pancreático, que não pode ser definitivamente classificada em pancreatite edematosa ou necrosante. Nesse caso, as atuais diretrizes recomendam

- A) realizar o exame precocemente, nas primeiras 24 horas após a admissão do paciente na emergência, para delimitar a área de necrose.
- B) classificar o caso como indeterminado e a realização de um exame de controle em 5-7 dias para definir a classificação do caso.
- C) que ela seja realizada em 10 a 14 dias após o início do quadro clínico, já que a necrose, em geral, se estabelece neste período.
- D) realizar o exame sem contraste iodado, pois este pode causar agravo do processo inflamatório pancreático.
- E) realizar a tomografia em todos os casos de pancreatite aguda, mesmo nos casos leves com apresentação clínica clássica.

39) Com relação à hemorragia digestiva alta (HDA) varicosa, assinale a alternativa correta.

- A) A reserva da função hepática não tem relação com o prognóstico na HDA por varizes.
- B) O uso de betabloqueadores não seletivos não ajuda a diminuir o risco de hemorragia por varizes.
- C) O fator principal da fisiopatologia da hipertensão portal é a diminuição da resistência hepática ao fluxo sanguíneo.
- D) São preditores da ruptura das varizes o tamanho do vaso e a reserva de função hepática.
- E) É a etiologia mais prevalente de HDA nas emergências.

40) É(São) considerado(s) fator(es) predisponente(s) ao câncer da vesícula biliar:

- A) idade precoce (3^a-4^a décadas).
- B) gênero masculino.
- C) cálculos < 3 cm.
- D) colelitíase.

E) pólipo < 10 mm.

41) Em relação à alimentação de um recém-nascido, filho de mãe HIV positiva, em uso de antirretroviral, o Ministério da Saúde recomenda oferecer:

A) aleitamento materno exclusivo.

B) aleitamento materno cruzado.

C) leite materno pausterizado.

D) aleitamento misto.

E) fórmula infantil.

42) Para avaliar o desenvolvimento motor de um lactente de 10 meses, está indicado verificar a capacidade de

A) pegar objetos e levar à boca.

B) sustentar o seu corpo nas próprias pernas.

C) andar sem apoio.

D) sentar-se com e sem apoio.

E) demonstrar lateralidade – se é dextro ou canhoto.

43) Gestante com diagnóstico de doença hipertensiva da gestação, dá entrada no centro obstétrico com 29 semanas de idade gestacional, em pré-eclâmpsia e com sinais de sofrimento fetal agudo, sendo submetida a parto cesáreo. Ao ser extraído, o recém-nascido está hipotônico e não apresenta movimento respiratório. Em relação ao clampeamento de cordão, está indicado ser realizado

A) imediatamente, para não atrasar os procedimentos de reanimação.

B) logo após o cordão ser ordenhado, para garantir bons índices hematimétricos da criança.

C) após 30 segundos de nascimento, para melhor estabilidade cardiovascular do recém-nascido.

D) entre 30 e 60 segundos, para favorecer a estabilização cardiovascular materna e do bebê.

E) após 60 segundos, para permitir a estabilização da pressão arterial materna.

44) Gestante com diagnóstico de doença hipertensiva da gestação, dá entrada no centro obstétrico com 29 semanas de idade gestacional, em pré-eclâmpsia e com sinais de sofrimento fetal agudo, sendo submetida a parto cesáreo. Ao ser extraído, o recém-nascido está hipotônico e não apresenta movimento respiratório. Após o clampeamento do cordão o recém-nascido foi levado para a mesa de reanimação, colocado sob fonte de calor radiante, em saco plástico e com touca, posicionado em decúbito dorsal com o pescoço em leve extensão e monitorado. Após esses procedimentos iniciais realizados no primeiro minuto, verifica-se que o recém-nascido apresenta frequência cardíaca de 120 bpm, movimentos

respiratórios espontâneos, porém com sinais de desconforto respiratório, saturando 67%. Nesse momento está indicado

- A) aspirar as vias aéreas.
- B) aplicar CPAP por meio de ventilador mecânico manual e máscara facial.
- C) realizar ventilação com pressão positiva e oferta de O₂ a 30%.
- D) proceder intubação orotraqueal.
- E) iniciar massagem cardíaca.

45) Recém-nascido à termo, filho de mãe diabética, com 3 horas de vida, glicemia de 38 mg/dL, mas está assintomático. A conduta indicada nesse momento é

- A) oferecer leite materno e repetir a dosagem após 30 minutos.
- B) oferecer solução glicosada por via oral.
- C) realizar minibolo intravenoso com 2 mL/kg de solução glicosada a 10%.
- D) prescrever infusão intravenosa de soro glicosado com velocidade de infusão de 4 mg/kg/min.
- E) oferecer 20 mL de fórmula infantil em copinho.

46) Adolescente de 14 anos, previamente hígida, está em uso de amoxicilina há 4 dias devido a quadro de amigdalite. Retorna ao pronto-socorro por persistência da febre, prostração e aparecimento de edema palpebral e manchas na pele. Ao exame físico, está em regular estado geral, apresentando edema palpebral discreto, adenomegalia cervical bilateral, orofaringe hiperemiada com exsudato em amígdalas, esplenomegalia discreta e rash cutâneo. De acordo com a principal hipótese diagnóstica, a conduta indicada é

- A) prescrever anti-histamínico e trocar a amoxicilina para macrolídeo, pois está apresentando reação alérgica ao antibiótico.
- B) fazer dose de penicilina benzatina, pois o quadro é compatível com escarlatina.
- C) substituir o antibiótico para cefalosporina de segunda geração, para ampliar a cobertura para agente produtor de beta-lactamase.
- D) fazer teste rápido e colher cultura de orofaringe para definir o antimicrobiano a ser prescrito.
- E) suspender o antibiótico e solicitar sorologia para Epstein-Barr.

47) Menina de 1 ano de idade, sem doenças de base, com vacinação em dia de acordo com o programa nacional de imunizações, é levada ao pronto-socorro com história de 12 horas de febre de 39,5 °C de início súbito, acompanhada de queda do estado geral, tosse, rinorreia, rouquidão e choro ao deglutir. Teve contato com adulto com gripe. Ao exame físico, está em regular estado geral, febril, com hiperemia de orofaringe, com ausculta pulmonar com roncocal de transmissão, saturando 95% em ar ambiente. Radiografia de tórax sem alterações. Teste rápido para COVID-19 negativo. A conduta indicada é

- A) orientar sintomáticos e retorno se necessário.
- B) prescrever antitérmico e amoxicilina.
- C) prescrever antitérmico e osetalmivir.
- D) colher hemograma, hemocultura e proteína C reativa para definir a conduta.
- E) prescrever hidratação parenteral, antitérmico, oxigenioterapia e deixar em observação hospitalar.

48) Menino de 4 anos, está internado em unidade de terapia intensiva devido pneumonia e insuficiência respiratória. A cultura de secreção traqueal revelou *Pseudomonas aeruginosa* e *Staphylococcus aureus*. Tem antecedente íleo meconical ao nascimento, pneumonias de repetição, diarreia crônica e baixo ganho pômdero-estatural. A doença de base provável é:

- A) Síndrome de imunodeficiência adquirida.
- B) Imunodeficiência combinada grave.
- C) Fibrose cística.
- D) Tuberculose.
- E) Deficiência de alfa-1 antitripsina.

49) Menina de 3 anos de idade, previamente hígida, há 1 semana iniciou quadro febril associado a hiperemia conjuntival. Foi avaliada no início do quadro, sendo orientado apenas antitérmico. Retorna ao pronto-socorro devido persistência do quadro e aparecimento de exantema. Ao exame físico, está em regular estado geral, febril, com hiperemia conjuntival bilateral sem secreção, hiperemia de mucosa oral, edema de dedos de mãos e pés, apresentando linfonodo cervical unilateral de 2 cm e exantema macular em tronco, membros, acompanhado de descamação em períneo. A principal hipótese diagnóstica é:

- A) Escarlatina.
- B) Sarampo.
- C) Síndrome mão-pé-boca.
- D) Adenite bacteriana.
- E) Doença de Kawasaki.

50) Adolescente de 14 anos, previamente hígida, iniciou com quadro súbito de falta de ar, dor abdominal e edema de lábios, 2 horas após retornar de uma festa. Ao exame físico, apresentando taquicardia, desconforto respiratório, edema de lábios e língua, estridor inspiratório e placas eritematosas em pescoço e tronco. De acordo com a principal hipótese diagnóstica, a conduta inicial deve ser a prescrição de:

- A) Salbutamol inalatório.
- B) Metilprednisolona intravenosa.
- C) Prometazina intramuscular.
- D) Adrenalina intramuscular.
- E) Prednisona oral.

51) Menino de 7 anos, apresenta diarreia crônica acompanhada de tenesmo e episódios de prolapso retal. Os exames laboratoriais confirmaram presença de sangue oculto nas fezes e anemia ferropriva. Esse quadro é sugestivo de qual parasitose intestinal?

- A) Tricuríase.
- B) Ancilostomíase.
- C) Ascaridíase.
- D) Enterobíase.
- E) Giardíase.

52) Menina de 4 anos de idade foi levada ao pediatra devido sangramento nasal e gengival há 3 dias. A mãe refere apenas que ela teve quadro febril há 1 semana, tratado com anti-inflamatório não hormonal. Ao exame físico, está em bom estado geral, afebril, apresentando petéquias em membros superiores e prova do laço positiva. Restante do exame físico, normal. Os exames laboratoriais revelaram: Hb = 11,7 mg/dL, Ht = 38%, leucócitos = 9300/mm³ (2% bastonetes, 49% segmentados, 3% monócitos, 1% eosinófilos, 45% linfócitos), plaquetas = 27000/mm³, tempo de protrombina = 13,2 seg (INR = 1,02), tempo de tromboplastina parcial ativada = 34 seg, tempo de trombina = 15,8 seg. A principal hipótese diagnóstica é:

- A) Dengue.
- B) Leucemia linfocítica aguda.
- C) Doença de von Willebrand.
- D) Trombocitopenia imune primária.
- E) Púrpura de Henoch-Schonlein.

53) Menina de 5 anos de idade, com antecedente de infecções urinárias de repetição e refluxo vésico-ureteral grau III bilateral, coletou exame de urina, por jato médio, 1 semana após terminar tratamento de infecção urinária com cefalexina. Está assintomática no momento. O exame de sedimento urinário revelou: pH = 6,0, densidade de 1015, leucócitos = 8000/mm³, eritrócitos = 2000/mm³, proteínas +/4, nitrito negativo, esterase leucocitária negativa, bacterioscopia com bacilos gram negativos. Urocultura com 20000 UFC de E.coli. Frente a esses achados, a hipótese diagnóstica é:

- A) Vulvovaginite.
- B) Cistite por bactéria resistente.
- C) Pielonefrite crônica.
- D) Síndrome nefrótica.
- E) Bacteriúria assintomática.

54) Menino com 6 meses de idade foi levado ao pronto-socorro com quadro de febre, diarreia líquida, vômitos e diminuição da aceitação alimentar e da diurese há 2 dias. Ao exame físico, está em regular estado geral, irritado, com fontanela deprimida, com mucosas secas, turgor da pele diminuído, taquicárdico, com pulso periférico diminuído e tempo de

enchimento capilar de 4 segundos. A conduta inicialmente indicada é

- A) dar alta com orientação de soro de reidratação oral, ondansetrona, antitérmico e retorno se sinais de alerta.
- B) iniciar terapia de reidratação oral 50 mL/kg a ser oferecida em ambiente hospitalar no período de 4 a 6 horas, com cálculo do índice de retenção após a 1ª hora.
- C) prescrever metoclopramida intramuscular e oferecer terapia de reidratação oral 100 mL/kg, por sonda nasogástrica, no período de 4 a 6 horas.
- D) prescrever soro de expansão intravenoso – soro fisiológico 20 mL/kg em 20 minutos.
- E) internar e introduzir soro de manutenção 100 kcal/kg em 24 horas, utilizando-se soro glicosado a 10% associado a soro fisiológico e cloreto de potássio 19,1%.

55) Adolescente de 13 anos deu entrada no pronto-socorro em primodescompensação diabética. Além da hiperglicemia e cetonúria, o distúrbio metabólico mais provável de ser encontrado nos exames laboratoriais iniciais é:

- A) Hipernatremia.
- B) Hipocalcemia.
- C) Hipercalemia.
- D) Osmolaridade sérica diminuída.
- E) Acidose metabólica com ânion gap aumentado.

56) Menina de 9 anos, com antecedente de impetigo há 2 semanas, tratado com neomicina tópica, apresenta há 2 dias edema de face, urina mais escura, cefaleia e prostração. Ao exame físico, apresenta edema periorbitário bilateral, pressão arterial entre o percentil 95 e 99 para a idade e sexo, lesões cicatriciais na pele. A principal hipótese diagnóstica é:

- A) Síndrome nefrótica.
- B) Glomerulonefrite difusa aguda.
- C) Hipertensão arterial primária.
- D) Febre reumática.
- E) Celulite infecciosa.

57) Menino de 2 anos está em atendimento na sala de emergência devido a quadro agudo de palidez e sonolência, sendo identificados: hipotermia, hipotensão, depressão respiratória, bradicardia, miose e hiporreflexia. Esse quadro é sugestivo de

- A) maus tratos.
- B) sepse.
- C) intoxicação aguda por opiáceo.
- D) meningoencefalite aguda.
- E) traumatismo craniano.

58) Menina de 2 anos de idade realizou hemograma de rotina, apresentando: número de eritrócitos aumentado, hemoglobina reduzida, volume corpuscular médio diminuído, coeficiente de variação de eritrócitos normal e poiquilocitose no esfregaço de sangue periférico. Qual dos exames laboratoriais abaixo é compatível com a principal hipótese etiológica para esse quadro?

- A) Vitamina B12 diminuída.
- B) Padrão ASF no teste de triagem neonatal.
- C) Ferritina diminuída.
- D) Eletroforese de hemoglobina com aumento da fração A2.
- E) Número de reticulócitos diminuído.

59) Para qual caso descrito abaixo está indicado a vacina pneumocócica 23-valente?

- A) Menino de 6 meses de idade com quadro de imunodeficiência combinada grave.
- B) Menina de 1 ano com episódios de pneumonias de repetição.
- C) Menino de 3 anos com síndrome de Down.
- D) Menina de 5 anos de idade com antecedente de prematuridade.
- E) Adolescente de 14 anos de idade com asma não controlada.

60) Menino de 2 anos de idade, com antecedente de cardiopatia congênita operada, está na sala de emergência devido parada cardiorrespiratória. Foram iniciadas as compressões torácicas e ventilação com ambu e máscara, mantendo pulsos ausentes. Ao ser acoplado ao monitor, verifica-se atividade elétrica com ritmo lento, QRS alargado. A conduta, nesse momento, deve ser:

- A) administrar epinefrina 0,01 mg/kg.
- B) infundir atropina 0,02 mg/kg.
- C) aplicar desfibrilação 2 J/kg.
- D) realizar intubação orotraqueal.
- E) parar as manobras de ressuscitação.

61) M.F.B., 23 anos, primigesta, deu entrada no PSO com queixa de sangramento vaginal em pequena quantidade. Dor tipo cólica, leve. Ao exame especular: colo uterino sem lesões. Pequena quantidade de sangue vermelho vivo coletado em fórnice posterior. Ao toque vaginal bimanual: fundo uterino na altura da sínfise púbica, colo uterino impérvio, grosso e posterior. Submetida a ultrassom que identificou: feto único, gestação tópica, CCN 52,5 mm, TN 1,1 mm; BCF inaudível, biometria compatível com 12 semanas de idade gestacional. Assinale o diagnóstico correto.

- A) Aborto retido.
- B) Aborto completo.
- C) Aborto incompleto.
- D) Gestação de mola incompleta.

E) Gestação heterotópica.

62) M.F.B., 23 anos, primigesta, deu entrada no PSO com queixa de sangramento vaginal em pequena quantidade. Dor tipo cólica, leve. Ao exame especular: colo uterino sem lesões. Pequena quantidade de sangue vermelho vivo coletado em fórnice posterior. Ao toque vaginal bimanual: fundo uterino na altura da sínfise púbica, colo uterino impérvio, grosso e posterior. Submetida a ultrassom que identificou: feto único, gestação tópica, CCN 52,5 mm, TN 1,1 mm; BCF inaudível, biometria compatível com 12 semanas de idade gestacional. Assinale a alternativa com a conduta correta.

- A) Orientar abstinência sexual e repouso relativo.
- B) Internação para cerclagem uterina.
- C) Repetir ultrassom em cerca de 7 dias para reavaliar desenvolvimento fetal.
- D) Internação para AMIU (aspiração manual intrauterina).
- E) Internação para Misoprostol e curetagem uterina posterior, se necessário.

63) N.T.B., 32 anos, GII P0 AI, IG, pelo ultrassom (usg) precoce, de 34 semanas e 4 dias, deu entrada no PSO com queixa de dor tipo contração uterina. Nega comorbidades ou outros sintomas. Ao toque vaginal: colo 3 cm, fino, anterior, bolsa íntegra, apresentação cefálica. BCF 148 bpm, DU 2/10'/30". De acordo com o caso, assinale a conduta correta.

- A) Corticoide e parto cesáreo.
- B) Sulfato de magnésio e condução do trabalho de parto com ocitocina.
- C) Corticoide e indução do trabalho de parto com misoprostol.
- D) Sulfato de magnésio e inibição do trabalho de parto com terbutalina.
- E) Conduta expectante, com reavaliação do toque vaginal em cerca de 1-2 horas.

64) O ultrassom morfológico de primeiro trimestre proporciona o cálculo do risco de trissomias, de acordo com a idade materna e a avaliação de outros marcadores durante o exame. Assinale a alternativa que relata apenas marcadores maiores para cromossomopatias.

- A) Osso nasal, translucência nugal, IP médio das artérias uterinas.
- B) Osso nasal, ducto venoso e translucência nugal.
- C) Translucência intracraniana, ducto venoso, osso nasal.
- D) IP médio das artérias uterinas, artéria umbilical única, osso nasal.
- E) Regurgitação da tricúspide, ducto venoso e pielectasia.

65) E.S.S., 29 anos, primigesta, IG por usg precoce de 28 semanas e 3 dias. Hipertensa crônica, em uso de metildopa 2 g/dia, deu entrada no PSO com ultrassom demonstrando diástole zero em artéria umbilical, peso fetal no percentil 6, ducto venoso IP: 0,50, maior bolsão vertical de 3 cm. Assintomática, PA de 130 x 80 mmHg. Assinale a conduta correta.

- A) Corticoide, sulfato de magnésio e interrupção da gestação via alta.
- B) Interrupção da gestação via alta de emergência, sem medidas prévias.

C) Corticoide, sulfato de magnésio por iminência de eclâmpsia e indução do trabalho de parto com Misoprostol.

D) Alta e retorno semanal para controle da vitalidade fetal.

E) Internação para controle diário do doppler do ducto venoso.

66) E.S.S, 29 anos, primigesta, IG por usg precoce de 28 semanas e 3 dias. Hipertensa crônica, em uso de metildopa 2 g/dia, deu entrada no PSO com ultrassom demonstrando diástole zero em artéria umbilical, peso fetal no percentil 6, ducto venoso IP: 0,50, maior bolsão vertical de 3 cm. Assintomática, PA de 130 x 80 mmHg. Diante do caso, assinale a interpretação correta, em relação a diástole zero em artéria umbilical, ilustrada a seguir.



A) Baixo índice de pulsatilidade em artéria umbilical.

B) Provavelmente a artéria cerebral média encontra-se com alto índice de pulsatilidade.

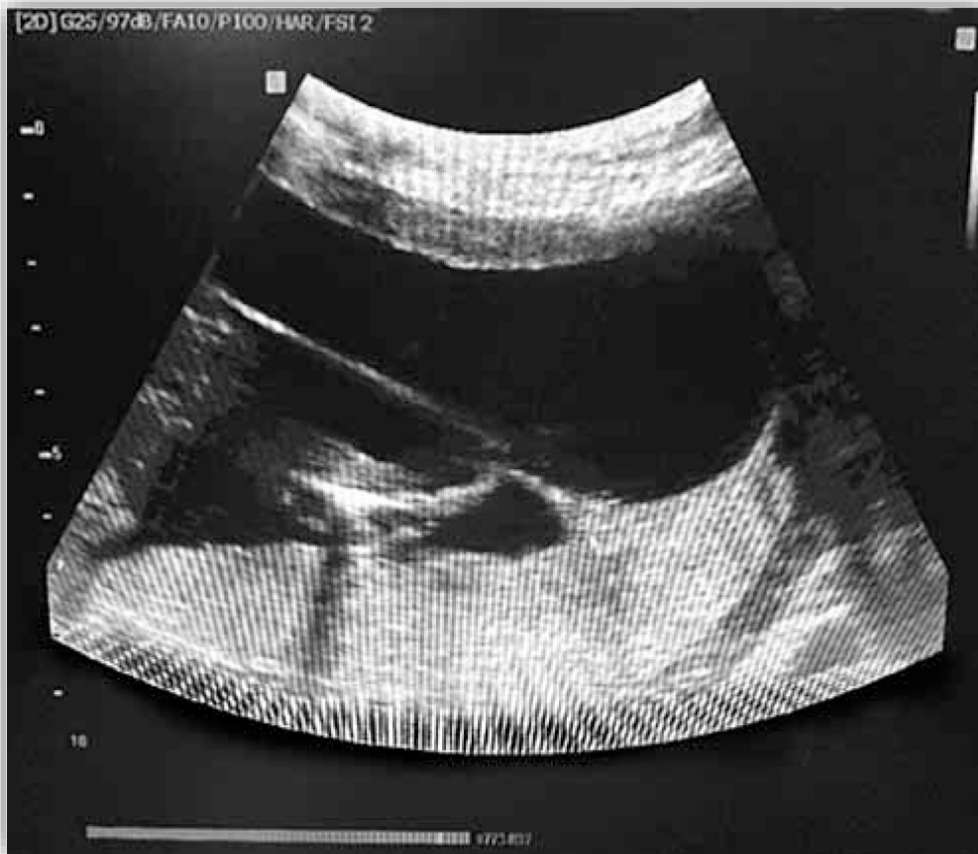
C) Provavelmente há um aumento da relação cérebro-umbilical.

D) Provavelmente a relação cérebro-umbilical está normal.

E) O ducto venoso pode estar normal.

67) G.J.N., 36 anos, GII PI 1C (há 3 anos) A0, deu entrada no PSO com queixa de dor em hipogástrio. IG de 20 semanas por USG prévio. Gestação gemelar, porém, de corionicidade desconhecida. Submetida à ultrassonografia após o primeiro atendimento. Imagem da

placenta identificada, conforme ilustração a seguir. De acordo com a imagem, assinale a classificação CORRETA da gestação gemelar e o sinal identificado.



- A) Dicoriônica e monoamniótica, sinal do T.
- B) Dicoriônica e diamniótica, sinal do Lambda.
- C) Monocoriônica e monoamniótica, sem sinal do T ou do Lambda.
- D) Monocoriônica e diamniótica, sinal do T.
- E) Monocoriônica e triamniótica, sinal do T.

68) K.G.B., 32 anos, GII PI(1N) A0, IG 37 semanas, sem comorbidades, veio à consulta de pré-natal de rotina com resultado de ultrassom obstétrico demonstrando ILA (índice de líquido amniótico) de 4,5 cm e MBV (maior bolsão vertical) de 1,8 cm. Peso fetal no percentil 63, placenta posterior, grau II, feto em apresentação cefálica. Paciente sem queixas obstétricas. EF obstétrico sem alterações. Feto com boa vitalidade. De acordo com o caso dado, assinale a conduta correta.

- A) Retorno em 3 dias para reavaliação do ILA.
- B) Retorno ao pré-natal em 7 dias.
- C) Internação para interrupção da gestação por via alta.
- D) Internação para indução do trabalho de parto com misoprostol.
- E) Internação para preparo do colo uterino com sonda de Foley.

69) C.S.A., 24 anos, primigesta, IG 31 semanas, encaminhada do pré-natal por elevação de PA, assintomática. Nega hipertensão prévia. Sem uso de medicação anti-hipertensiva. Ao exame físico: PA 150 x 100 mmHg, AU: 25 cm, DU ausente, colo uterino impérvio, BCF 158 bpm. Ultrassom pela medicina fetal do mesmo dia demonstrando feto em apresentação cefálica, peso fetal no percentil 3, diástole zero em artéria umbilical, ducto venoso IP: 0,60. Assinale a primeira abordagem que deve ser feita diante do caso a seguir.

- A) Metildopa, sulfato de magnésio e rotina pré-eclâmpsia.
- B) Hidralazina EV, corticoide e sulfato de magnésio.
- C) Levomepromazina, hidralazina EV e rotina pré-eclâmpsia.
- D) Anlodipino, corticoide, rotina pré-eclâmpsia, sulfato de magnésio e SVD.
- E) Anlodipino, rotina pré-eclâmpsia, controle de PA e avaliação da vitalidade fetal.

70) C.S.A., 24 anos, primigesta, IG 31 semanas, encaminhada do pré-natal por elevação de PA, assintomática. Nega hipertensão prévia. Sem uso de medicação anti-hipertensiva. Ao exame físico: PA 150 x 100 mmHg, AU: 25 cm, DU ausente, colo uterino impérvio, BCF 158 bpm. Ultrassom pela medicina fetal do mesmo dia demonstrando feto em apresentação cefálica, peso fetal no percentil 3, diástole zero em artéria umbilical, ducto venoso IP: 0,60. Após resultados de exames, identificados: plaquetas: 82000; TGO 140; TGP 100; DHL 900; ácido úrico 7, assinale o diagnóstico correto.

- A) Pré-eclâmpsia leve.
- B) Pré-eclâmpsia super-ajuntada.
- C) Síndrome HELLP.
- D) Eclâmpsia.
- E) Hipertensão gestacional.

71) C.S.A., 24 anos, primigesta, IG 31 semanas, encaminhada do pré-natal por elevação de PA, assintomática. Nega hipertensão prévia. Sem uso de medicação anti-hipertensiva. Ao exame físico: PA 150 x 100 mmHg, AU: 25 cm, DU ausente, colo uterino impérvio, BCF 158 bpm. Ultrassom pela medicina fetal do mesmo dia demonstrando feto em apresentação cefálica, peso fetal no percentil 3, diástole zero em artéria umbilical, ducto venoso IP: 0,60. Assinale a conduta mais adequada.

- A) Corticoide, sulfato de magnésio e interrupção da gestação via alta.
- B) Sulfato de magnésio e indução do trabalho de parto com misoprostol.
- C) Corticoide e indução do trabalho de parto com misoprostol.
- D) Corticoide e repetir rotina pré-eclâmpsia em 24 horas.
- E) Corticoide, sulfato de magnésio e repetir rotina pré-eclâmpsia em 48 horas.

72) O conhecimento da flora normal e os mecanismos envolvidos com a sua manutenção são indispensáveis para os diagnósticos etiológicos das vulvovaginites. No diagnóstico da vaginose bacteriana, observa-se o seguinte:

- A) pH < 4,5.
- B) aumento de lactobacilos.
- C) resposta inflamatória exacerbada.
- D) células-guia (clue cells).
- E) presença de pseudo-hifas.

73) A SOP (síndrome dos ovários policísticos) é um relevante problema de saúde pública, que provoca alterações metabólicas, reprodutivas e psicológicas significativas. É uma das condições mórbidas mais comuns em mulheres no menacme, afetando de 8 a 13% das pacientes em idade reprodutiva. Assinale a alternativa que demonstra causas importantes da perda da qualidade de vida dessas mulheres.

- A) Distúrbio menstrual e peso normal.
- B) Alopecia e amenorreia.
- C) Sobrepeso e varizes.
- D) Depressão e dismenorreia.
- E) Hirsutismo e obesidade.

74) A SOP (síndrome dos ovários policísticos) é um relevante problema de saúde pública, que provoca alterações metabólicas, reprodutivas e psicológicas significativas. É uma das condições mórbidas mais comuns em mulheres no menacme, afetando de 8 a 13% das pacientes em idade reprodutiva. Assinale a alternativa que indica o câncer em que a anovulação crônica da SOP predispõe.

- A) Tireoide.
- B) Fígado.
- C) Endométrio.
- D) Cólon.
- E) Colo uterino.

75) G.B.D., 34 anos, vem ao ginecologista por atraso menstrual de 18 dias. Exames laboratoriais: beta HCG negativo, níveis de FSH, LH e estradiol normais. Progesterona com valor abaixo do esperado. De acordo com o caso, assinale a alternativa que indica a atual situação da paciente.

- A) Presença de corpo lúteo persistente.
- B) Ausência de ovulação nesse ciclo.
- C) Paciente encontra-se na segunda fase do ciclo.
- D) Paciente apresenta atrofia endometrial.
- E) Há uma provável insuficiência ovariana precoce.

76) A população folicular vai se reduzindo ao longo da vida, culminando com a falência ovariana, característica da menopausa. Assinale a alternativa que indica a idade em que a

menopausa geralmente ocorre.

- A) 30 anos de idade.
- B) 40 anos de idade.
- C) 50 anos de idade.
- D) 60 anos de idade.
- E) 70 anos de idade.

77) Para organizar a associação entre algumas importantes comorbidades ou características da mulher e os métodos anticoncepcionais, usam-se os critérios de elegibilidade da Organização Mundial da Saúde. Assinale a alternativa que indica situações em que a classificação é de categoria 4 para o uso do sistema intrauterino de levonorgestrel (DIU-LNG) e para o DIU de cobre, respectivamente.

- A) Antecedente pessoal de trombose venosa profunda; câncer de mama atual.
- B) Enxaqueca com aura; adenoma hepático.
- C) Câncer de mama atual; leiomioma submucoso.
- D) Imediatamente após aborto; sangramento uterino anormal por leiomioma subseroso.
- E) LES com Ac Antifosfolípide (+); imediatamente após aborto.

78) Mulher, idade: 63 anos, apresenta queixa de urgência miccional. A paciente relata que o sintoma iniciou há, aproximadamente, 1 ano, associado a episódios de aumento da frequência miccional diurna e noctúria. Nega perda urinária quando tosse, relata hipertensão arterial sistêmica controlada com medicação anti-hipertensiva e nega outras comorbidades. Durante história gineco-obstétrica, a paciente relata menopausa aos 52 anos de idade e três gestações prévias, todas com partos via vaginal. Refere consumo abundante de café e chás. Ao exame físico, apresenta sinais de hipoestrogenismo genital, ausência de prolapsos e teste de perda de urina aos esforços negativo. O IMC da paciente é 30 kg/m². Assinale a principal hipótese diagnóstica para o caso apresentado, e o exame complementar que deve ser sugerido para a investigação inicial, respectivamente.

- A) Incontinência urinária de estresse; estudo urodinâmico.
- B) Incontinência urinária mista; cistoscopia.
- C) Bexiga hiperativa; urina tipo I e urocultura.
- D) Incontinência urinária de estresse; urina tipo I e urocultura.
- E) Incontinência urinária mista; estudo urodinâmico.

79) A endometriose é uma afecção muito mais comum do que se imagina, principalmente nos estádios iniciais. Por isso, se quisermos fazer o diagnóstico correto, é necessário estar muito atento à queixa clínica da paciente, e, posteriormente, associar a exame físico e de imagem. Com relação a um marcador de endometriose profunda, assinale a alternativa correta.

- A) Endometriomas.

- B) Fluido nos ovários.
- C) Defeito peritoneal.
- D) Hipervascularização.
- E) Dismenorreia severa.

80) O câncer de mama é a neoplasia mais frequente no mundo entre as mulheres, excluindo as neoplasias de pele não melanoma. Sobre sua incidência, carcinogênese, rastreamento e tratamento, assinale a alternativa correta.

- A) O câncer de mama hereditário é responsável por cerca de 70% dos cânceres mamários.
- B) De acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer), o rastreamento com mamografia deve ser bienal, em mulheres de 50 a 69 anos de idade.
- C) Características de microcalcificações pleomórficas, amorfas e agrupadas na mamografia são sugestivas de lesões benignas.
- D) Nódulos hipodensos, mais largos do que altos e lobulados à mamografia, são sugestivos de lesões malignas.
- E) A radioterapia adjuvante à cirurgia não possui finalidade curativa.

81) Assinale a alternativa que apresenta alguns dos principais procedimentos e cuidados em atenção domicilar (AD) do Sistema Único de Saúde (SUS).

- A) Instalação de punções venosas centrais com colocação de cateter e realização de pequenas cirurgias.
- B) Realização de pequenas cirurgias e de procedimentos de higienização e manobras de alívio intestinal.
- C) Troca de cânula, higienização e descanulação em paciente traqueostomizado e troca da bolsa, higienização e curativos em paciente com colostomia.
- D) Realização de traqueostomia e prestação de serviços de cuidados com a manutenção do cateter, evitando a obstrução, curativo e fixação em punções venosas periféricas.
- E) Instalação de port cath em punção venosa central e realização de troca de sonda nasogástrica, fixação e higienização.

82) A secretaria de saúde de um município de 40 mil habitantes detecta aumento de queixas de lombalgia e dores nos braços de mulheres entre 25 a 40 anos de idade, de uma determinada região no segundo semestre de 2017 a 2019 e novamente no mesmo período de 2019 e 2020. Ao investigar os casos, identifica-se que muitas delas trabalham em uma empresa de confecção de porte médio, cortando tecidos e costurando, e, no segundo semestre, a empresa aumenta muito a produção das roupas para as vendas do final do ano, sem que haja contratações adicionais. Assinale a alternativa correta.

- A) Mulheres na faixa etária entre 25 e 40 anos costumam ter sobrecarga musculoesquelética por causa dos afazeres domésticos e filhos pequenos e assim, o quadro de dor deve ser decorrente desses aspectos.

B) Após avaliação ortopédica, deve ser instituído tratamento medicamentoso, e a secretaria de saúde deve sugerir à empresa que sejam contratados trabalhadores homens para substituir as mulheres.

C) A ocorrência de dores musculoesqueléticas se dá quando a empresa não proporciona fisioterapia preventiva.

D) A história sugere a ocorrência de distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, que são de notificação compulsória no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

E) Mulheres costumam ter distúrbios hormonais que resultam em dores musculoesqueléticas e essa deve ser a primeira hipótese a ser investigada.

83) A Convenção-Quadro da OMS para o Controle do Tabaco (CQCT), primeiro tratado internacional de saúde pública da história da humanidade, tem como objetivo proteger as gerações presentes e futuras das devastadoras consequências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas geradas pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco. Assinale a alternativa correta sobre o tabagismo.

A) Entre os diversos recursos utilizados para o controle do tabaco no Brasil está a divulgação do uso do cigarro eletrônico.

B) Proibição da venda de produtos de tabaco a menores de idade e do uso de descritores light, suave, leve fazem parte da legislação que visa ao controle do tabagismo.

C) A diminuição do preço do cigarro acaba redundando na piora da qualidade do cigarro, o que aumenta o risco para a saúde.

D) O aumento do preço do cigarro tem pouco impacto no tabagismo, pois os maiores consumidores são os mais ricos e os mais jovens.

E) Os estudos recentes mostram que o fumante passivo pode sofrer reações alérgicas, mas não tem risco aumentado para doenças mais graves.

84) A Rede de Atenção Psicossocial tem como finalidade a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS. Assinale a alternativa que apresenta objetivos específicos da Rede de Atenção Psicossocial.

A) Reduzir danos provocados pelo consumo de crack, álcool e outras drogas e produzir e ofertar informações sobre direitos das pessoas, medidas de prevenção e cuidado e os serviços disponíveis na rede.

B) Promover cuidados em saúde especialmente para grupos mais vulneráveis (crianças, adolescentes e jovens, pessoas em situação de rua e populações indígenas) e eliminar a dependência de crack, álcool e outras drogas.

C) Fornecer conhecimento sobre os efeitos nocivos do crack, álcool e outras drogas para grupos mais vulneráveis a fim de que não se tornem dependentes e promover mecanismos de formação permanente aos profissionais de saúde.

D) Instituir bônus e benefícios para os dependentes de crack, álcool e outras drogas que abandonem o hábito e monitorar e avaliar a qualidade dos serviços por meio de indicadores de efetividade e resolutividade da atenção.

E) Promover a reabilitação e a reinserção das pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas na sociedade, por meio do acesso a informações, e oferecer mecanismos de formação permanente aos profissionais de saúde.

85) Relaciona-se com o conceito de clínica ampliada:

A) rigor do diagnóstico médico para que o plano terapêutico seja instituído de forma adequada.

B) acesso a exames complementares de alta complexidade para que o diagnóstico seja feito de forma precisa.

C) acesso a hospitais precocemente para que pacientes com quadros clínicos graves tenham tratamento preciso e possam se recuperar.

D) acesso às mais diversas especialidades para que o quadro clínico seja bem caracterizado, e o tratamento seja abrangente.

E) abordagem de cada caso de maneira a considerar os diversos elementos que compõem e interferem no quadro clínico e terapêutico, incluindo questões sociais.

86) Assinale a alternativa que apresenta o indicador de saúde possível de se obter por meio de um estudo de Coorte, que outros delineamentos epidemiológicos não fornecem.

A) Coeficiente de mortalidade por determinada doença.

B) Risco relativo.

C) Coeficiente de prevalência.

D) Coeficiente de letalidade.

E) Índice de Swaroop & Uemura.

87) O Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de janeiro de 2020 informava que no período de início de julho/2019 a janeiro de 2020, haviam sido notificados 1.087 eventos envolvendo a morte de macacos com suspeita de febre amarela, das quais 38 epizootias haviam sido confirmadas por critério laboratorial, 300 descartadas, 361 permaneciam em investigação e 388 haviam sido classificadas como indeterminadas, por não disponibilidade de amostra para diagnóstico. Assinale a alternativa correta sobre a febre amarela.

A) A vacina contra a febre amarela foi excluída do Calendário Nacional de Vacinação por falta de insumos.

B) O grande número de mortes de macacos notificadas como suspeitas e descartadas revela falta de qualidade no sistema de notificação.

C) A vigilância de epizootias em primatas não humanos (PNH) tem o objetivo de prevenir a ocorrência de casos humanos de febre amarela.

D) Considera-se PNH doente o animal que apresenta comportamento anormal, cujas características principais são a irritabilidade e a agressividade.

E) O Sistema de Vigilância de Epizootias em PNH tem como marco inicial o ano de 2020, com a eclosão da pandemia de covid-19.

88) Uma agência bancária teve um surto de covid-19 em maio de 2020, com 7 casos de pessoas doentes. Uma das bancárias foi internada, mas não intubada. Após 7 dias de internação recebeu alta, mas ficou afastada por um mês com fraqueza e dificuldade mesmo para andar. Ao retornar ao trabalho, percebeu que não se sentia como se sentia antes de ter a doença, em particular no que se referia à memória, além de sentir sempre uma névoa na cabeça. Assinale a alternativa correta.

A) Somente o caso da bancária deve ser notificado no SINAN como relacionado ao trabalho, pois se trata de covid-19 longa.

B) Os casos não devem ser notificados no SINAN, pois o caráter ocupacional só se aplica aos trabalhadores da saúde, e o quadro da bancária é de covid-19 longa.

C) Os casos devem ser notificados no SINAN apenas se houver comprovação de que a transmissão foi no local de trabalho, e o quadro da bancária é de covid-19 longa.

D) Os casos devem ser notificados no SINAN como relacionados ao trabalho, e o quadro descrito é compatível com covid-19 longa.

E) Somente o caso da bancária deve ser notificado no SINAN como relacionado ao trabalho, bem como daqueles que tiveram contato direto com ela.

89) João atravessou uma área de enchente para chegar em casa e 7 dias depois começou a ter febre, cefaleia, náuseas e vômitos. Procurou o serviço de urgência e constatou-se icterícia alaranjada. Assinale a alternativa correta.

A) O caso é compatível com leptospirose, e João deve ser internado para antibioticoterapia e outros cuidados; a notificação deve ser feita imediatamente no SINAN.

B) O caso é compatível com leptospirose, e João deve ser orientado para fazer uso de antibióticos e se hidratar com frequência; a notificação no SINAN deve ser feita no prazo de uma semana.

C) Embora possa ser leptospirose, não se descarta também febre amarela, e João deve ser internado para investigação; não há necessidade de notificação no SINAN.

D) O período de incubação de 7 dias é demasiadamente curto para ser leptospirose, mas João deve ser internado para investigação; o caso só deve ser notificado no SINAN após diagnóstico de certeza.

E) O período de incubação de 7 dias é demasiadamente curto para ser leptospirose, e o quadro não é característico; João deve ser encaminhado para investigação na UBS e não deve haver notificação no SINAN.

90) Assinale a alternativa que apresenta aspectos relacionados à longitudinalidade do cuidado.

- A) Tratamento continuado, identificação com o profissional de saúde e continuidade informacional.
- B) Identificação da unidade básica como fonte regular de cuidado, vínculo do cuidado duradouro e continuidade informacional.
- C) Resolutividade, identificação com o profissional de saúde e vínculo do cuidado duradouro.
- D) Cuidado centrado na pessoa, compromisso do médico com o paciente e tratamento continuado.
- E) Rigor no diagnóstico médico, identificação do médico com o paciente e tratamento adequado e continuado.

91) Sobre a varíola do macaco, assinale a alternativa correta.

- A) Trata-se de uma zoonose que apareceu recentemente, totalmente desconhecida pela ciência.
- B) A transmissibilidade da doença se dá principalmente por via aérea, mas pode ocorrer por contato íntimo.
- C) Os fatos recentes indicam que haverá uma pandemia da doença semelhante a de covid-19.
- D) O paciente confirmado deve se manter em isolamento até que a erupção cutânea esteja totalmente resolvida.
- E) Trata-se de uma arbovirose transmitida para humanos por meio do contato com animal ou humano infectado, de alta letalidade.

92) O senhor Alfredo e a dona Miriam têm, respectivamente, 80 e 78 anos de idade, e são casados há 60 anos. Moram em uma cidade de 50 mil habitantes e seus filhos e netos moram em uma cidade de maior porte a, aproximadamente, 150 quilômetros. Em um final de semana, o senhor Alfredo passa mal, é levado ao serviço de urgência por um vizinho, e a dona Miriam recebe a notícia de que ele sofreu um acidente vascular cerebral. Após vários dias no hospital, recebe alta com hemiparesia à esquerda e afasia. Assinale a alternativa correta quanto ao processo de recuperação do senhor Alfredo.

- A) Os filhos do casal devem abrigá-lo, ficando o senhor Alfredo com quem tem melhores condições de moradia, pois haverá necessidade de cuidadores.
- B) A equipe de saúde da atenção básica deve buscar uma possibilidade de internar o senhor Alfredo em hospital de longa permanência para aliviar a carga de dona Miriam e convocar a família para que os seus membros os levem para a outra cidade.
- C) O hospital deve orientar o casal a buscar acomodações próximas ao serviço de reabilitação que a unidade de serviço oferece ambulatorialmente.
- D) A equipe de saúde da atenção básica deve convocar os filhos do casal e orientá-los no sentido de que o casal necessitará de cuidadores durante 24 horas por dia para que o senhor Alfredo possa se recuperar.

E) A equipe de saúde da atenção básica deve analisar o caso, levando em conta que o senhor Alfredo necessitará de reabilitação e atenção que talvez dona Miriam não poderá oferecer, e construir com a família a melhor forma de prosseguir os cuidados.

93) Analisando o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) de uma cidade, a secretaria de saúde identifica como importante causa básica de morte por causa externa, queda sem especificação, de crianças e adolescentes. Ao investigar essas mortes, percebe-se que um grande percentual se deu por queda de uma laje, que depois se verifica ser de uma obra em construção, de fácil acesso e que serve de área de lazer nos finais de semana. Assinale a alternativa correta sobre esse caso.

A) Como a prefeitura não pode interferir em propriedade privada, deve solicitar à justiça um pedido para que possa interditar a obra.

B) A interdição da obra é obrigatória, pois se trata de problema de saúde pública.

C) A prefeitura deve intimar os proprietários a providenciarem um isolamento da área de forma que o acesso de quaisquer pessoas seja impedido.

D) A prefeitura deve providenciar uma placa informando que o acesso às obras é proibido.

E) A prefeitura deve fazer uma campanha em massa, com a colaboração da rádio local para que os pais proibam as crianças e adolescentes de irem à obra.

94) Assinale a alternativa correta em casos de mortes naturais sem assistência médica, ocorridos em domicílio, em município que conta com Instituto Médico Legal (IML) e Serviço de Verificação de Óbito (SVO).

A) A declaração de óbito (DO) deve ser preenchida por médico do SVO.

B) Qualquer médico pode preencher a DO.

C) É obrigação do médico de um serviço de urgência e emergência preencher a DO.

D) O responsável pelo falecido, acompanhado de duas testemunhas, deve comparecer ao cartório do registro civil, que preenche as três vias da DO.

E) A DO deve ser preenchida por um médico do IML.

95) Um senhor é atropelado por um carro. É internado com lesões de órgãos internos e evolui a óbito após 5 dias por infecção generalizada. Assinale a alternativa que apresenta a causa básica do óbito.

A) Septicemia.

B) Parada cardiorrespiratória.

C) Lesão de órgãos internos.

D) Choque séptico.

E) Vítima de atropelamento por veículo motorizado.

96) É vedado ao médico

- A) deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.
- B) informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta for avalizada pelos familiares mais próximos.
- C) exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos, salvo se for para aumentar a adesão do paciente às condutas médicas.
- D) abandonar o paciente, em hipótese alguma, por ser este portador de moléstia crônica ou incurável, devendo continuar a assisti-lo ainda que para cuidados paliativos.
- E) abreviar a vida do paciente, salvo nos casos em que houver um pedido deste ou de seu representante legal.

97) Assinale a alternativa correta sobre o cadastramento dos usuários do SUS no Sistema Cartão.

- A) Da população prisional poderão ser cadastrados apenas os indivíduos que têm pena menor do que 10 anos.
- B) Os ciganos nômades e os moradores de rua estão dispensados de apresentarem o endereço do domicílio permanente.
- C) Os brasileiros residentes no exterior e estrangeiros não residentes no país não poderão ser cadastrados como usuários do SUS.
- D) Os dados e as informações individuais dos usuários do SUS são armazenados sob sigilo, podendo um médico revelá-los caso julgue imprescindível.
- E) Os moradores das ocupações de terras são excluídos do cadastramento do Sistema Cartão.

98) É vedado ao médico

- A) assumir emprego, cargo ou função para suceder médico demitido ou afastado em represália à atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria, salvo exceções.
- B) desrespeitar a prescrição ou o tratamento de paciente, determinados por outro médico, sem exceção.
- C) deixar de fornecer a outro médico informações sobre o quadro clínico de paciente, mesmo sem o seu conhecimento ou de seu representante legal.
- D) revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.
- E) deixar de revelar aos pais ou representantes legais a condição de saúde relacionada a paciente menor de idade.

99) Assinale a alternativa que apresenta um dos princípios da seguridade social, segundo a Constituição Federal.

- A) Uniformidade da base de financiamento.
- B) Participação na gestão administrativa de representantes dos aposentados e do governo, sendo vetados os dos empresários.
- C) Universalidade da cobertura e do atendimento.
- D) Redução do valor dos benefícios em casos de calamidade pública.
- E) Uniformidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, salvo exceções previstas em lei.

100) Assinale a alternativa correta sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

- A) A RENAME tem acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica qualquer cidadão cadastrado no Sistema Cartão.
- B) A RENAME não tem complementação estadual ou municipal.
- C) O Ministério da Saúde tem total autonomia para dispor sobre a RENAME.
- D) A RENAME é atualizada anualmente.
- E) A RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.

GABARITO

1	11	21	31	41	51	61	71	81	91
E	C	B	D	E	A	A	A	C	D
2	12	22	32	42	52	62	72	82	92
D	C	E	C	B	D	E	D	D	E
3	13	23	33	43	53	63	73	83	93
C	D	C	E	A	E	E	E	B	C
4	14	24	34	44	54	64	74	84	94
B	D	D	B	B	B	B	C	A	A
5	15	25	35	45	55	65	75	85	95
A	A	A	C	A	E	E	B	E	E
6	16	26	36	46	56	66	76	86	96
C	A	A	C	E	B	E	C	X	A
7	17	27	37	47	57	67	77	87	97
E	A	E	A	C	C	B	C	C	B
8	18	28	38	48	58	68	78	88	98
E	E	B	B	C	D	D	C	D	D
9	19	29	39	49	59	69	79	89	99
B	B	C	D	E	C	E	A	A	C
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
C	D	A	D	D	A	C	B	B	E